



GUÍA BREVE | RECURSO GRATUITO

RAZONAMIENTO CLÍNICO MUSCULOESQUELÉTICO

Evaluar, interpretar y comunicar más allá de la etiqueta
diagnóstica

Una introducción práctica para estudiantes y profesionales de la salud MSK

EDUCACIÓN · EVIDENCIA CIENTÍFICA · RAZONAMIENTO CLÍNICO MSK

Acerca de esta guía

KineCheck | Educación, evidencia científica y razonamiento clínico MSK. Edición breve para distribución gratuita, octubre de 2026.

Esta guía introduce un método para organizar la evaluación musculoesquelética desde la seguridad hasta la reevaluación. Resume conceptos que pueden cambiar decisiones clínicas y omite deliberadamente el desarrollo exhaustivo de técnicas, protocolos regionales, dosificación avanzada y análisis metodológico. Su propósito es orientar el razonamiento, no sustituir una formación completa.

Nota editorial: el contenido tiene fines educativos y no reemplaza la valoración clínica individual, la coordinación interdisciplinaria cuando corresponde ni las normativas sanitarias y competencias profesionales aplicables en cada país.

Cómo usarla

- Lea los capítulos en secuencia la primera vez; después úselos como mapa de consulta.
- En los microcasos, formule una hipótesis antes de revisar la lectura razonada.
- Use las fuentes clave para ampliar temas que requieran mayor profundidad.
- Adapte toda decisión a la persona, al contexto y a la evolución clínica.

KINECHECK | CLAVE CLÍNICA

Una evaluación útil no acumula pruebas: busca la información con mayor posibilidad de cambiar seguridad, hipótesis o conducta.



Índice

- Presentación
- 1. De la etiqueta diagnóstica al razonamiento clínico
- 2. Dolor, nocicepción y contexto
- 3. Seguridad antes que especificidad
- 4. Anamnesis que cambia decisiones
- 5. Examen físico: medir para responder preguntas
- 6. Imagenología: utilidad y límites
- 7. Comunicación clínica como intervención
- 8. Del examen al plan terapéutico
- 9. Ejercicio como herramienta terapéutica
- 10. Microcasos integradores
- Algoritmo de consulta
- Bibliografía consolidada

La ruta del eBook

Comprender	Evaluar	Decidir	Revisar
Nombrar el problema con la certeza disponible.	Priorizar seguridad y obtener datos útiles.	Acordar un plan funcional y viable.	Observar respuesta y ajustar el rumbo.



Presentación

Una consulta musculoesquelética suele comenzar con dolor, una actividad perdida o un diagnóstico previo. El desafío no consiste en encontrar una etiqueta cada vez más precisa, sino en integrar historia, examen, contexto y evolución para decidir qué requiere atención, qué hipótesis son plausibles y qué plan tiene sentido para esa persona.

La evidencia informa probabilidades y opciones; la experiencia clínica ayuda a reconocer patrones y límites; las preferencias del paciente definen qué resultados importan y qué alternativas son viables. Ninguna de estas fuentes decide por sí sola.

En cuadros frecuentes, una prueba única rara vez explica toda la presentación. Los síntomas pueden relacionarse con tejidos, sistema nervioso, carga, sueño, experiencias previas, trabajo, expectativas y entorno. Reconocer esta interacción no significa negar la biología ni atribuir el dolor a la mente. Significa describir con precisión qué sabemos, qué inferimos y qué debemos revisar.

KINECHECK | PREGUNTA DE RAZONAMIENTO

Si solo pudiera obtener un dato adicional hoy, ¿cuál tendría mayor posibilidad de cambiar su conducta clínica?



Figura 1. Ruta breve del razonamiento clínico: evaluar, decidir, explicar y volver a medir.

CAPÍTULO 1

De la etiqueta diagnóstica al razonamiento clínico

Un diagnóstico orienta cuando resume información útil. Se vuelve problemático cuando sustituye el razonamiento o comunica más certeza de la que existe.

Cuatro niveles que conviene distinguir

Nivel	Pregunta	Ejemplo
Estructural	¿Qué tejido o enfermedad se identificó?	Fractura confirmada por imagen.
Clínico	¿Qué patrón organiza síntomas y signos?	Dolor de hombro relacionado con carga.
Funcional	¿Qué actividad o participación está limitada?	No puede alcanzar un estante en el trabajo.
Inespecífico	¿No se identificó una causa específica que cambie el manejo?	Dolor lumbar inespecífico tras evaluación proporcionada.

Estos niveles pueden coexistir. Una imagen puede describir un cambio estructural, mientras la evaluación clínica define su relevancia y el diagnóstico funcional muestra por qué importa. El término inespecífico no significa imaginario ni irrelevante; indica que no se atribuye el cuadro, con suficiente confianza, a una estructura única que exija un manejo distinto.

El nombre también comunica

Estudios con escenarios de dolor lumbar han observado que etiquetas anatómicas o degenerativas pueden aumentar la intención de solicitar imagen, cirugía o segunda opinión frente a etiquetas menos amenazantes. Son resultados sobre percepciones e intenciones, no una demostración de que una palabra determine por sí sola la evolución. La explicación, el tono y la historia previa también influyen [1,2].

KINECHECK | ERROR FRECUENTE

Convertir un hallazgo de imagen en una explicación causal completa, o usar inespecífico como sinónimo de no hay nada.

KINECHECK | COMUNICACIÓN

Podemos nombrar el patrón que observamos y, al mismo tiempo, ser honestos sobre lo que no puede atribuirse a una estructura única.

Fuentes clave: [1-4]

CAPÍTULO 2

Dolor, nocicepción y contexto

Dolor y daño pueden relacionarse, pero no son equivalentes. Comprender esa diferencia evita tanto el reduccionismo estructural como la negación de los tejidos.

Tres conceptos distintos

Concepto	Descripción breve	Implicación
Nocicepción	Procesamiento neural de estímulos potencialmente dañinos.	Puede ocurrir sin dolor consciente.
Dolor	Experiencia sensorial y emocional personal.	No se infiere solo por actividad nociceptiva.
Daño tisular	Alteración biológica de un tejido.	Puede existir con dolor variable o sin dolor.

La definición revisada de la IASP reconoce la influencia de factores biológicos, psicológicos y sociales, y señala que el relato de la persona debe respetarse. Esto no convierte el dolor en una idea ni significa que todo dolor esté en el cerebro. El dolor emerge de un organismo completo: tejidos, sistema nervioso, experiencias, expectativas y contexto participan de maneras variables [5].



Figura 2. El dolor se interpreta integrando tejidos, sistema nervioso, experiencia y contexto.

Descriptores de mecanismo

Descriptor	Cuándo considerarlo	Límite
Nociceptivo	Evidencia de activación nociceptiva por lesión o amenaza tisular.	No identifica por sí solo el tejido responsable.
Neuropático	Lesión o enfermedad del sistema somatosensorial con distribución y signos compatibles.	Parestesia aislada no basta.
Nociplástico	Nocicepción alterada sin evidencia suficiente de daño o lesión somatosensorial que explique el dolor.	Requiere criterios y exclusiones razonables.

Sensibilización describe aumento de respuesta de neuronas nociceptivas. No puede concluirse únicamente por dolor intenso, duración prolongada o una puntuación elevada en un cuestionario. Es una hipótesis que debe formularse con prudencia [6-8].

KINECHECK | APLICACIÓN CLÍNICA

Explique que el dolor es real, que los tejidos importan y que la intensidad no funciona como un medidor directo y exacto de daño.

Fuentes clave: [5-8]



CAPÍTULO 3

Seguridad antes que especificidad

El triage busca reconocer situaciones que requieren otra urgencia, otra disciplina o una evaluación adicional antes de perseguir una etiqueta precisa.

Las banderas son datos, no diagnósticos

Una bandera roja aislada rara vez confirma patología grave. Su valor depende de prevalencia, combinación de hallazgos, evolución y contexto. Algunas son frecuentes y poco específicas; otras, aunque raras, merecen atención por su gravedad potencial. La decisión debe integrar la historia completa y el examen dirigido [9-11].

Dominio	Ejemplos que justifican profundizar	Posible conducta
Trauma o hueso	Trauma relevante, fragilidad, uso prolongado de corticoides, dolor óseo focal.	Regla de decisión o evaluación médica/imágenes según contexto.
Sistémico	Fiebre, malestar, pérdida de peso no explicada, inmunosupresión, antecedentes oncológicos.	Ampliar historia, signos vitales y coordinación.
Neurológico	Déficit progresivo, alteraciones esfinterianas, anestesia en silla de montar.	Derivación urgente según presentación.
Vascular	Dolor desproporcionado, cambios de color/temperatura, disnea o edema inesperado.	Evaluación inmediata según sospecha.
Psicosocial	Temor intenso, ánimo muy bajo, barreras laborales, señales de crisis.	Adaptar manejo y coordinar apoyo; no equivale a causa psicológica.

SALUD MUSCULOESQUELÉTICA

Una secuencia práctica de triage



Figura 3. El triage orienta una conducta proporcional al riesgo y a la evolución.

KINECHECK | CLAVE CLÍNICA

La ausencia de una bandera no garantiza seguridad absoluta, y su presencia aislada no confirma enfermedad grave. El curso y la reevaluación también forman parte del triage.

Fuentes clave: [9-12]

CAPÍTULO 4

Anamnesis que cambia decisiones

La entrevista clínica organiza la incertidumbre. Debe descubrir lo que puede modificar seguridad, hipótesis, pronóstico o plan.

Ocho dominios esenciales

Dominio	Preguntas posibles	Qué informa
Motivo	¿Qué le preocupa y qué necesita recuperar?	Prioridad y criterio de éxito.
Síntomas	¿Dónde empieza, se extiende y qué sensación nota?	Patrón y diferencial.
Tiempo	¿Cuándo comenzó y cómo ha cambiado?	Curso y urgencia.
Carga	¿Qué lo provoca, cuánto tarda en ceder y qué ocurre después?	Irritabilidad y tolerancia.
Seguridad	¿Trauma, fiebre, malestar, déficit progresivo u otros cambios?	Triage.
Función	¿Qué tarea, trabajo, sueño o participación afecta?	Medidas y objetivos.
Creencias	¿Qué cree que ocurre y qué teme?	Educación y lenguaje.
Contexto	¿Qué tratamientos, apoyos y barreras existen?	Viabilidad del plan.

Severidad no equivale a gravedad

Una escala de dolor puede ayudar al seguimiento, pero no es un medidor de daño. Vincule intensidad con interferencia, comportamiento y función. Irritabilidad describe cuánta carga provoca síntomas, cuánto aumentan y cuánto tardan en volver a un nivel aceptable; esta información ayuda a elegir el orden del examen y la dosis inicial.

Cierre con un resumen de retorno

Resuma con palabras simples y pida corrección: Entiendo que empezó al aumentar las horas de trabajo, que le preocupa una lesión grave y que su prioridad es volver a dormir y entrenar. ¿Lo entendí bien? Este paso verifica datos y muestra si profesional y paciente están trabajando sobre el mismo problema.

KINECHECK | ERROR FRECUENTE

Completar un formulario exhaustivo y omitir la actividad que la persona necesita recuperar o la explicación que más teme.

Fuentes clave: [4,12-14]

CAPÍTULO 5

Examen físico: medir para responder preguntas

El examen produce evidencia cuando cada procedimiento responde una pregunta y su resultado puede modificar una decisión.

Del objetivo a la prueba

Antes de medir, formule la duda: ¿hay déficit neurológico?, ¿qué movimiento limita la tarea?, ¿la fuerza está reducida por dolor o por déficit motor?, ¿qué carga reproduce el problema?, ¿qué medida servirá para reevaluar? Esta formulación evita aplicar baterías rutinarias sin utilidad clínica.

Componente	Aporta	Precaución
Inspección	Edema, deformidad, protección, estrategias de movimiento.	Una postura aislada no demuestra causalidad.
ROM activo/pasivo	Movilidad, tolerancia, control y punto final.	Registrar posición, dolor y compensación.
Fuerza	Capacidad contráctil estimada o cuantificada.	MMT es ordinal; dinamometría exige estandarización.
Neurológico	Sensibilidad, fuerza, reflejos y distribución.	Interpretar conjunto y evolución.
Prueba especial	Puede aumentar o reducir una probabilidad.	Rara vez establece un diagnóstico sola.
Prueba funcional	Desempeño en una tarea relevante.	Elegir una demanda segura y repetible.

Sensibilidad, especificidad y likelihood ratios

Medida	Pregunta sencilla	Uso clínico
Sensibilidad	Entre quienes tienen la condición, ¿cuántos dan positivo?	Una prueba muy sensible ayuda más cuando es negativa.
Especificidad	Entre quienes no la tienen, ¿cuántos dan negativo?	Una prueba muy específica ayuda más cuando es positiva.
LR+	¿Cuánto más probable es un positivo con la condición?	Valores mayores aumentan más la probabilidad.
LR-	¿Cuánto cambia un negativo la probabilidad?	Valores cercanos a cero reducen más la probabilidad.

El resultado se interpreta desde una probabilidad previa. Si esa probabilidad es muy baja, un positivo modesto puede seguir dejando incertidumbre; si es alta, un negativo débil puede no descartar. Los clusters solo son útiles cuando están validados y aplicados en poblaciones comparables.

KINECHECK | PREGUNTA DE RAZONAMIENTO

¿Qué resultado de esta prueba cambiaría realmente lo que hará hoy?



CAPÍTULO 6

Imagenología: utilidad y límites

Una imagen es valiosa cuando responde una pregunta clínica y su resultado puede cambiar el manejo. Fuera de ese contexto puede añadir ruido y amenaza.

Hallazgo no equivale a causa

Cambios degenerativos y otras variaciones aparecen en personas con y sin dolor. La frecuencia suele aumentar con la edad. Esto no vuelve irrelevante la imagen: obliga a interpretarla junto con región, síntomas, mecanismo, examen y evolución [3,18,19,25].

Región	Hallazgos posibles en personas sin síntomas	Pregunta clínica
Columna	Degeneración discal, protrusiones y otros cambios relacionados con edad.	¿Existe concordancia y cambia el manejo?
Hombro	Cambios tendinosos o del manguito rotador.	¿La presentación exige imagen o puede iniciarse manejo conservador?
Rodilla	Características de osteoartritis en RM.	¿El hallazgo explica la limitación o solo describe estructura?

Cuándo puede aportar

- Trauma o sospecha de lesión cuya confirmación cambiaría la conducta.
- Sospecha de patología grave o déficit neurológico relevante.
- Curso inesperado o falta de respuesta que obliga a revisar el diagnóstico.
- Planificación de un procedimiento cuando la información anatómica es necesaria.

En dolor lumbar, NICE desaconseja la imagen rutinaria en atención no especializada y propone considerarla en contextos especializados si es probable que cambie el manejo [20]. Las reglas y normativas locales deben respetarse.

KINECHECK | COMUNICACIÓN

La imagen muestra cambios reales, pero necesitamos comprobar cuáles coinciden con sus síntomas y cuáles son frecuentes en personas sin dolor.

Fuentes clave: [3,18-20,25]

CAPÍTULO 7

Comunicación clínica como intervención

Las palabras cambian lo que una persona entiende, espera y decide. Comunicar bien no significa tranquilizar sin fundamento, sino explicar con honestidad y utilidad.

Un modelo en cuatro movimientos



Figura 4. Cuatro movimientos para una explicación clínica honesta y útil.

Qué evitar y cómo reformular

Evitar	Una alternativa más útil
Su columna está desgastada.	La imagen muestra cambios frecuentes con la edad; veremos cuánto se relacionan con sus síntomas.
No tiene nada.	No encontramos señales de una condición grave; sí hay un problema real de dolor y función que podemos abordar.
Debe fortalecer el core porque está inestable.	Trabajaremos fuerza y tolerancia para que vuelva a las tareas que necesita.
El dolor está en su cerebro.	El dolor es una experiencia real en la que participan tejidos, sistema nervioso y contexto.
Esto se arregla en seis semanas.	La evolución varía; revisaremos función y respuesta para ajustar el plan.

Comunicar incertidumbre

Una explicación útil distingue certeza de hipótesis: Con lo evaluado hoy, lo más probable es..., no encontramos..., todavía necesitamos observar.... Añada un plan para reducir la incertidumbre: qué se hará, qué se medirá y qué cambios justificarán reevaluación o derivación.

Compruebe comprensión pidiendo a la persona que explique con sus palabras el plan y las señales de alerta. No es un examen; permite detectar si la comunicación fue clara.

Fuentes clave: [1,2,12-14]

CAPÍTULO 8

Del examen al plan terapéutico

El plan no se deriva automáticamente de un hallazgo. Se construye al conectar interpretación, prioridades, opciones y respuesta.

La cadena de decisión

Paso	Pregunta
Hallazgo	¿Qué observé y cómo lo medí?
Interpretación	¿Qué significa en esta persona y qué no puedo concluir?
Hipótesis	¿Qué explicación provisional integra mejor los datos?
Decisión	¿Qué conducta cambia por esta información?
Intervención	¿Qué opción es segura, viable y coherente con el objetivo?
Reevaluación	¿Qué resultado indicará mantener, progresar o revisar?

La CIF como mapa

La CIF ayuda a relacionar funciones y estructuras corporales con actividad, participación y factores contextuales [4]. Un problema prioritario no es necesariamente el hallazgo más llamativo; suele ser el que más limita una actividad relevante o bloquea el avance del plan.

Objetivos verificables

Un objetivo clínico útil describe una actividad, una condición y un horizonte razonable: subir dos pisos para llegar al trabajo con una respuesta tolerable y recuperarse antes del día siguiente. El dolor puede medirse, pero conviene acompañarlo de función, confianza, carga tolerada y participación.

KINECHECK | APLICACIÓN CLÍNICA

Registre una hipótesis, una medida funcional y un criterio de revisión. Si la respuesta no coincide con lo esperado, revise el razonamiento antes de aumentar la dosis.

Fuentes clave: [4,12-14]

CAPÍTULO 9

Ejercicio como herramienta terapéutica

El ejercicio se selecciona y dosifica para una persona, una función y un contexto. No existe una modalidad universalmente superior para todos los trastornos MSK.

Principios que suelen importar más que el nombre

Principio	Aplicación
Relevancia	Relacionar el ejercicio con una tarea o capacidad importante.
Dosis	Definir frecuencia, intensidad, volumen, descanso y exposición.
Tolerancia	Observar respuesta durante, después y al día siguiente.
Progresión	Modificar una variable cuando la respuesta sea estable y el objetivo lo justifique.
Preferencia	Elegir opciones aceptables, accesibles y compatibles con la rutina.
Adherencia	Reducir complejidad, acordar mínimos viables y anticipar barreras.

Respuesta a la carga

La presencia de síntomas durante el ejercicio no implica automáticamente daño. Interprete intensidad, calidad, duración, pérdida de función y recuperación. Una respuesta leve y transitoria puede ser compatible con progresión; un aumento marcado, sostenido o acompañado de nuevos signos requiere reducir, modificar o reevaluar.



Figura 5. La progresión depende de la respuesta durante, después y al día siguiente.

Fuerza, actividad aeróbica y exposición

Estas herramientas pueden combinarse según el problema y las metas. En dolor lumbar persistente, las revisiones apoyan el ejercicio como una opción terapéutica, pero los efectos promedio y la superioridad entre modalidades varían. La decisión práctica debe considerar evidencia, preferencias, recursos y respuesta individual [12,14,17,21-23].

KINECHECK | ERROR FRECUENTE

Cambiar de ejercicio cada vez que aparece una molestia leve, o mantener una dosis que produce deterioro

sostenido solo porque estaba prescrita.

Fuentes clave: [12,14,17,21-23]

CAPÍTULO 10

Microcasos integradores

Los casos siguientes son ejercicios de razonamiento. No representan protocolos ni permiten trasladar una decisión sin reevaluar a la persona real.

MICROCASO 1

Dolor lumbar persistente

KINECHECK | CLAVE CLÍNICA

Información inicial. Persona de 44 años con dolor lumbar de ocho meses, fluctuante, sin trauma reciente. Mantiene sensibilidad y fuerza sin cambios progresivos. Una RM previa informó degeneración discal. Ha reducido caminatas porque teme desgastar más la columna.

Preguntas para detenerse

KINECHECK | PREGUNTA DE RAZONAMIENTO

¿Qué información falta para completar el triage? • ¿Qué significado atribuye a la RM? • ¿Qué tarea usaría como medida funcional?

Lectura razonada

La imagen puede influir en temor y conducta, pero no determina por sí sola la causa ni la capacidad. Primero se confirman signos de seguridad y luego se exploran carga, sueño, trabajo, expectativas y objetivos. La evitación es un factor modificable, no una prueba de que el dolor sea psicológico.

KINECHECK | COMUNICACIÓN

La imagen muestra cambios reales y frecuentes. Hoy no vemos señales de daño progresivo; podemos probar una exposición gradual y revisar cómo responde su función.

Plan inicial

Acordar caminatas breves a una dosis tolerable, una tarea de fuerza relacionada con su objetivo y educación sobre fluctuaciones. Elegir una medida de función y establecer criterios para aumentar, mantener o reducir.

Revisar tolerancia al día siguiente, distancia caminada, confianza y aparición de nuevos síntomas; si la trayectoria no coincide con lo esperado, reabrir el diagnóstico y el plan.

MICROCASO 2

Dolor de hombro relacionado con carga

KINECHECK | CLAVE CLÍNICA

Información inicial. Persona de 52 años con dolor gradual al elevar el brazo y dormir sobre ese lado. No hubo trauma ni pérdida súbita de fuerza. Trabaja con tareas sobre la cabeza y desea volver a nadar.

Preguntas para detenerse

KINECHECK | PREGUNTA DE RAZONAMIENTO

¿Qué hallazgos harían necesaria una evaluación adicional? • ¿Qué prueba funcional reproduce su demanda? • ¿La imagen cambiaría el manejo inicial?

Lectura razonada

La historia sugiere un cuadro relacionado con carga, pero la etiqueta tisular exacta puede permanecer incierta. El examen debe describir movimiento, fuerza, tolerancia y función; una prueba especial aislada no confirma el diagnóstico.

KINECHECK | COMUNICACIÓN

El patrón es compatible con un hombro sensible a la carga. No necesitamos atribuir todo a un tendón para comenzar un plan y observar la respuesta.

Plan inicial

Modificar temporalmente volumen sobre la cabeza, elegir ejercicios de fuerza y exposición compatibles con tolerancia, y mantener actividad general. Integrar una progresión específica hacia la natación.

Revisar sueño, rango útil, carga de trabajo tolerada y desempeño en una tarea elegida. Considerar imagen o coordinación si aparecen datos nuevos o la evolución es inesperada.

MICROCASO 3

Dolor cervical y trabajo

KINECHECK | CLAVE CLÍNICA

Información inicial. Persona de 35 años con dolor cervical recurrente durante semanas de alta demanda frente al computador. Refiere cefalea ocasional, sin trauma, fiebre, alteraciones visuales, pérdida de fuerza ni síntomas neurológicos progresivos.

Preguntas para detenerse

KINECHECK | PREGUNTA DE RAZONAMIENTO

¿Qué preguntas de seguridad necesita precisar? • ¿Qué papel podrían tener sueño, pausas y carga laboral?

- ¿Qué hallazgo serviría para seguimiento?

Lectura razonada

La asociación con trabajo no demuestra que una postura específica sea la causa. Conviene explorar comportamiento, cefalea, síntomas neurológicos, estado general, sueño, estrés y posibilidades reales de modificar tareas.

KINECHECK | COMUNICACIÓN

No observamos señales de alarma en la evaluación actual. Su cuello parece sensible a periodos prolongados y poca variación; trabajaremos tolerancia y opciones de movimiento.

Plan inicial

Acordar variación de posturas, pausas realistas, movilidad o fuerza según hallazgos y actividad física general. Evitar reglas rígidas de postura perfecta.

Revisar frecuencia de episodios, tolerancia laboral, sueño y signos nuevos. Si la cefalea cambia de patrón o aparecen datos de seguridad, ampliar evaluación o derivar.

MICROCASO 4

Dolor de rodilla en corredor recreativo

KINECHECK | CLAVE CLÍNICA

Información inicial. Persona de 29 años con dolor anterior de rodilla tras aumentar distancia y desnivel en tres semanas. No refiere bloqueo, derrame importante, trauma ni inestabilidad. Quiere mantener su participación en una carrera futura.

Preguntas para detenerse

KINECHECK | PREGUNTA DE RAZONAMIENTO

¿Qué cambio de carga coincide con el inicio? • ¿Qué pruebas representan la demanda de correr? • ¿Qué opción preserva participación sin prometer ausencia total de síntomas?

Lectura razonada

El aumento rápido de carga es relevante, pero no prueba una lesión estructural específica. El examen puede incluir fuerza, tolerancia a sentadilla o step-down, volumen actual y factores de recuperación. La decisión se apoya en función y respuesta, no en una prueba única.

KINECHECK | COMUNICACIÓN

La rodilla parece estar recibiendo más carga de la que tolera por ahora. Ajustaremos dosis sin asumir que está dañada o que debe detener toda actividad.

Plan inicial

Reducir temporalmente la variable más provocadora, mantener actividad tolerable, entrenar capacidades relevantes y planificar un retorno progresivo. Incorporar preferencias y calendario real.

Revisar respuesta de 24 horas, volumen semanal, confianza y tarea funcional. Si aparece derrame marcado, bloqueo, inestabilidad u otra evolución inesperada, reevaluar.

Algoritmo breve de consulta

Paso	Acción	Pregunta de control
1	Escuchar motivo, preocupación y objetivo.	¿Qué necesita comprender o recuperar?
2	Realizar triage proporcional.	¿Hay datos que cambien urgencia o disciplina?
3	Construir hipótesis iniciales.	¿Qué explica mejor el patrón y qué falta saber?
4	Elegir examen dirigido.	¿Qué resultado cambiaría la conducta?
5	Integrar y explicar.	¿Qué sabemos, qué inferimos y qué no sabemos?
6	Acordar intervención y medida.	¿Es segura, relevante, viable y verificable?
7	Reevaluar trayectoria.	¿Mantener, progresar, modificar o derivar?

KINECHECK | PREGUNTA FINAL

¿Qué dato nuevo haría que cambiara de hipótesis o de plan?

Lo que esta guía deja deliberadamente fuera

No desarrolla protocolos por región, reglas de decisión completas, propiedades métricas de cada instrumento, dosificación avanzada, intervenciones específicas ni lectura crítica extensa. Esos temas requieren formación adicional y consulta de guías actualizadas.

Bibliografía consolidada

1. O'Keeffe M, Traeger AC, Hoffmann TC, et al. Effect of diagnostic labelling on management intentions for non-specific low back pain: a randomized scenario-based experiment. *Eur J Pain*. 2022;26(7):1452-1464. doi:10.1002/ejp.1981.
2. Martin S, Smith M, Wilson DA, Zadro JR, Ferreira GE, O'Keeffe M. Non-specific diagnostic labels for musculoskeletal conditions foster positive views about prognosis and non-invasive management but require clear explanation: a systematic review. *J Physiother*. 2025;71(3):167-178. doi:10.1016/j.jphys.2025.06.011.
3. Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2015;36(4):811-816. doi:10.3174/ajnr.A4173.
4. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: WHO; 2001.
5. Raja SN, Carr DB, Cohen M, et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain*. 2020;161(9):1976-1982. doi:10.1097/j.pain.0000000000001939.
6. Finnerup NB, Haroutounian S, Kamerman P, et al. Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical practice. *Pain*. 2016;157(8):1599-1606. doi:10.1097/j.pain.0000000000000492.
7. Kosek E, Clauw D, Nijs J, et al. Chronic nociplastic pain affecting the musculoskeletal system: clinical criteria and grading system. *Pain*. 2021;162(11):2629-2634. doi:10.1097/j.pain.0000000000002324.
8. Adams GR, Gandhi W, Harrison R, van Reekum CM, Wood-Anderson D, Gilron I, et al. Do central sensitization questionnaires reflect measures of nociceptive sensitization or psychological constructs? A systematic review and meta-analyses. *Pain*. 2023;164(6):1222-1239. doi:10.1097/j.pain.0000000000002830.
9. Downie A, Williams CM, Henschke N, et al. Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low back pain: systematic review. *BMJ*. 2013;347:f7095. doi:10.1136/bmj.f7095.
10. Henschke N, Maher CG, Ostelo RWJG, de Vet HCW, Macaskill P, Irwig L. Red flags to screen for malignancy in patients with low-back pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;(2):CD008686. doi:10.1002/14651858.CD008686.pub2.
11. Dionne N, Adefolarin A, Kunzelman D, et al. What is the diagnostic accuracy of red flags related to cauda equina syndrome, when compared to MRI? A systematic review. *Musculoskelet Sci Pract*. 2019;42:125-133. doi:10.1016/j.msksp.2019.04.004.
12. Lin I, Wiles L, Waller R, et al. What does best practice care for musculoskeletal pain look like? Eleven consistent recommendations from high-quality clinical practice guidelines: systematic review. *Br J Sports Med*. 2020;54(2):79-86. doi:10.1136/bjsports-2018-099878.
13. National Institute for Health and Care Excellence. Shared decision making. NICE guideline NG197. London: NICE; 2021.

Bibliografía consolidada continuación

14. George SZ, Fritz JM, Silfies SP, et al. Interventions for the management of acute and chronic low back pain: revision 2021. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2021;51(11):CPG1-CPG60. doi:10.2519/jospt.2021.0304.
15. Gismervik SØ, Drogset JO, Granviken F, Rø M, Leivseth G. Physical examination tests of the shoulder: a systematic review and meta-analysis of diagnostic test performance. *BMC Musculoskelet Disord.* 2017;18:41. doi:10.1186/s12891-017-1400-0.
16. Hegedus EJ, Goode AP, Cook CE, et al. Which physical examination tests provide clinicians with the most value when examining the shoulder? *Br J Sports Med.* 2012;46(14):964-978. doi:10.1136/bjsports-2012-091066.
17. Desmeules F, Roy JS, Lafrance S, et al. Rotator cuff tendinopathy diagnosis, nonsurgical medical care, and rehabilitation: a clinical practice guideline. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2025;55(4):235-274. doi:10.2519/jospt.2025.13182.
18. Culvenor AG, Øiestad BE, Hart HF, Stefanik JJ, Guermazi A, Crossley KM. Prevalence of knee osteoarthritis features on magnetic resonance imaging in asymptomatic uninjured adults: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med.* 2019;53(20):1268-1278. doi:10.1136/bjsports-2018-099257.
19. Sanders SL, Ibounig T, Haas R, et al. Rotator cuff imaging abnormalities in asymptomatic shoulders: a systematic review. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2025;55(12):736-751. doi:10.2519/jospt.2025.13611.
20. National Institute for Health and Care Excellence. Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. NICE guideline NG59. London: NICE; 2016, updated 2020.
21. Hayden JA, Ellis J, Ogilvie R, Malmivaara A, van Tulder MW. Exercise therapy for chronic low back pain. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021;(9):CD009790. doi:10.1002/14651858.CD009790.pub2.
22. World Health Organization. WHO guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain in adults in primary and community care settings. Geneva: WHO; 2023.
23. World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO; 2020.
24. Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM, et al. Neck pain: revision 2017. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2017;47(7):A1-A83. doi:10.2519/jospt.2017.0302.
25. Brinjikji W, Diehn FE, Jarvik JG, et al. MRI findings of disc degeneration are more prevalent in adults with low back pain than in asymptomatic controls: a systematic review and meta-analysis. *AJNR Am J Neuroradiol.* 2015;36(12):2394-2399. doi:10.3174/ajnr.A4498.



Seguir aprendiendo

El razonamiento clínico no elimina la incertidumbre: la hace explícita, manejable y revisable. Una buena consulta integra seguridad, función, evidencia, preferencias y comunicación, y mantiene abierta la posibilidad de cambiar de rumbo cuando aparecen datos nuevos.

KINECHECK | PARA LLEVAR

Seguridad antes que especificidad. Preguntas antes que pruebas. Función antes que etiquetas.
Reevaluación antes que certeza.

Biblioteca gratuita KineCheck

Acceda a este y otros recursos educativos en: <https://kinecheck.cl/gratis/>

Educación, evidencia científica y razonamiento clínico MSK.

